Guía Práctica Clínica: Amenaza de parto pretérmino

CONEXIÓN CLÍNICA

Crecemos en Saber

1 TAMIZAJE



Tamizaje universal en TODA gestante entre las 18-24 semanas.

Tamizaje temprano en pacientes CON FACTORES DE RIESGO desde semanas 11-14 y semana 16.

¿Con qué realizarlo?

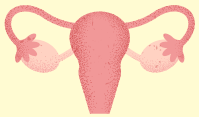
Cervicometría transvaginal.



¿Cómo interpreto la longitud cervical?

Longitud	Interpretación
≥25 mm	Normal Bajo riesgo
20-24 mm	Riesgo intermedio (individualizar)
<25 mm	Riesgo aumentado (candidata a progesterona si singleton)
<20 mm	Riesgo alto (posible cerclaje según antecedente)
<10-15 mm	Altísimo riesgo (probable incompetencia cervical)

2 PREVENCIÓN





Progesterona vaginal:

Desde semana 16-24 hasta semana 36-37:

- Progesterona vaginal micronizada 200 mg noche.
- Gel vaginal 90 mg/día.

Cerclaje:

Por historia:

- ≥ 1 pérdida gestacional 14–24 semanas por insuficiencia cervical.
- ≥ 1 parto pretérmino < 34 semanas por dilatación cervical indolora.

Por ultrasonido:

- Embarazo único.
- Antecedente de parto pretérmino < 34 semanas.
- Longitud cervical < 25 mm antes de las 24 semanas.

Por hallazgo físico:

- Dilatación cervical ≥ 1 cm.
- Membranas expuestas o en protrusión, entre 16–26 semanas.

3 CLASIFICACIÓN

	Definición
Amenaza de parto pretérmino	Dinámica uterina sin cambios cervicales.
Síndrome de parto pretérmino	Dinámica uterina con cambios cervicales (dilatación ≥2–3 cm o acortamiento progresivo).
Trabajo de parto pretérmino establecido	Dilatación ≥4–6 cm.
Ruptura prematura de membranas con dinámica	Ruptura espontánea de membranas con dinámica uterina.

4 MANEJO TERAPÉUTICO

Tocolisis: Máximo durante 48h**

¿Cuándo?

- Actividad uterina regular + modificación cervical.
- Edad gestacional 24–34 semanas.
- Necesidad de completar esteroides.
- Necesidad de neuroprotección fetal (< 32 semanas).
- Requerimiento de traslado a centro con UCI neonatal.

Nifedipino 20-30 mg carda, seguido de 10-20 mg c/6-8h.

Maduración pulmonar:

¿Cuándo?
Riesgo de parto pretérmino entre 24+0 y 34+6 semanas.

- Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis.
- Dexametasona 6 mg IM c/12h.

Neuroprotección:

¿Cuándo?
Riesgo de parto pretérmino entre 23+0 y 31+6 semanas.

Sulfato de Mg 4 mg IV en 20 min, mantenimiento 1 g/h x 12h o hasta el parto.

Antibióticos:

NO se recomiendan de rutina sin una clara indicación.

- ITU → dirigir según urocultivo.
- Vaginosis: metronidazol según esquema.

Monitoreo intrahospitalario:

- ☐ Signos vitales cada 4 horas.
- ☐ Frecuencia cardiaca fetal continua si disponible.
- ☐ Monitoreo de contracciones.
- ☐ Vigilancia de efectos adversos de tocolíticos.
- ☐ Revaloración cervical según necesidad.

5 FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO

- Corioamnionitis.
- Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI)
- Compromiso fetal.
- Trabajo de parto progresivo.
- Edad gestacional ≥34 semanas (individualizar según guías).

